# Efficacité du pantalon anti-choc non pneumatique dans la prise en charge de l'hémorragie du post-partum : Expérience du service de maternité du Centre médical avec antenne Chirurgicale de Dafra

**WONI F,** MEDA ZC, ILY I, SANOU S, ZAN A, DOUSSA B, SOME DA

CMA de Dafra, Région des Hauts-Bassins, Burkina Faso

# Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

# Introduction

- Hémorragie du post-partum (HPP) : 1ère cause de décès maternels

- Existence de nombreux moyens de la PEC de l'HPP

  Pantalon anti-choc non pneumatique ou ***Non Pneumatic Anti-Shock Garment*** **(NASG)** : un moyen utilisé à Dafra

# Introduction

## NASG et sa mise en place

**Quelle est la contribution du NASG dans la PEC de l'HPP au CMA Dafra?**

# Objectif

Evalué la contribution du NASG à la stabilisation hémodynamique, à la réduction des complications liées à l'HPP et au délai d'amélioration de l'état clinique

# Matériel et méthode(s)

- **Type et période**

  Etude quantitative transversale conduite du 1er Juillet 2023 au 31 Mai 2025

- **Site :** Maternité du CMA de Dafra

- **Critères d'inclusion**

  - Accouchée au CMA de Dafra et ayant présenté une HPP
  - Ayant bénéficié de l'application du NASG

- **Taille échantillon : 65 patientes**

# Matériel et méthode(s)

- **Collecte des données**
  - Menée du 1er février au 31 mai 2025
  - Instrument : **application Kobocollect**

- **Variables de l'étude pour apprécier les effets du NASG**
  - Caractéristiques sociodémographiques
  - Stabilisation des fonctions hémodynamiques si choc hypovolémique
  - Réduction des complications liées à l'HPP
  - Temps de récupération de la TAS ≥90mmHg après application

- **Analyse :** Microsoft Excel

# Résultats

**Tableau I :** répartition des patientes selon les caractéristiques sociodémographiques (n = 65)

| **Caractéristiques sociodémographiques** | **Résultats** |
|---|---|
| Age moyen (ans) | **27,4 ans** |
| Femme occupée au foyer | **92,3%** |
| Mariée | **98,5%** |
| Résidence | **Milieu urbain** (80%) |
| | secteur 15 (30,8 %) |

# Résultats

## Données à l'admission

- **Mode d'admission**
  - Evacuation : **50,8%**
  - auto-orientation : 30,8%
  - Référée : 18,5%

- **Motifs d'admission**
  - HPP : **50,77%**
  - Contractions utérines sur grossesse à terme : 26,15%

# Résultats

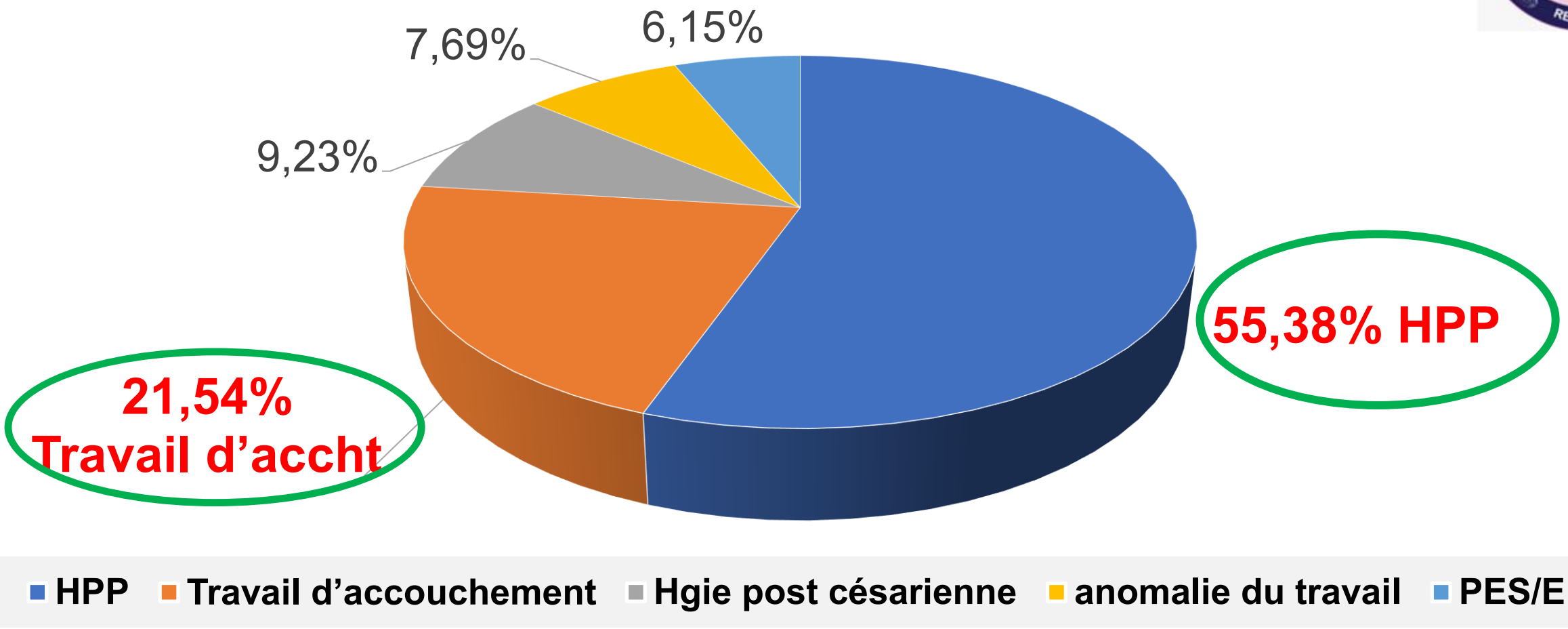


**Figure 1** : Diagnostic retenu à l'admission (n=65)

# Résultats

**Tableau II :** répartition des patientes selon les antécédents (n=65)

| Antécédents | Pourcentages (%) |
|---|---|
| **Paucigeste** | **49,3** |
| **Paucipare** | **40,0** |
| **Grossesse à terme** | **55,7** |
| Hémorragie post-partum | 06,2 |
| HTA/PES/E | 06,4 |
| ≥1 Césarienne | 16,4 |

# Résultats

**Tableau III :** répartition des femmes selon la caractéristique de l'HPP

| Caractéristique de l'HPP | Effectifs | Pourcentages |
|---|---|---|
| **Quantité de sang perdu (ml)** | | |
| <500 | 07 | 10,7 |
| 500-<1000 | 41 | **63,1** |
| ≥1000 | 17 | **26,2** |
| **Pendant l'accouchement** | | |
| Non | 22 | 33,8 |
| Oui | 43 | **66,2** |
| **Après l'accouchement** | | |
| Non | 14 | 21,5 |
| Oui | 51 | **78,5** |
| **Pendant la césarienne** | | |
| Non | 43 | 66,2 |
| Oui | 22 | **33,8** |
| **Taux d'Hb au contrôle** | **< 6,3g/dl** | **1,7%** |

# Résultats

**Tableau IV** : répartition des patientes selon l'étiologie de l'HPP

| Etiologie de l'HPP | Effectifs | Pourcentages |
|---|---|---|
| Tonus | 58,0 | 89,2 |
| Tissu | 12,0 | 18,5 |
| Traumatisme | 18,0 | 27,7 |
| Temps | 9,0 | 13,8 |

# Résultats

## Durée de contention du NASG chez la patiente

- Après traitement étiologique
- Application du **Non-pneumatic Anti-Shock Garment (**NASG) laissé en place pendant
  - **24h chez 73,8 % des patientes, et**
  - **48h chez 26,2 %**

# Résultats

## Transfusion pratiquée

- **Transfusée : 58 %**
- Total PSL transfusé : **747cc**
- Types de PSL
  - CGR : 50%
  - PFC : 5%
  - CGR +PFC : 4%

# Résultats

## Traitement utéro-tonique et chirurgical

- **Utérotonique (ocytocine) : 60 %**

- **Gestes pratiqués : 68%**
  - Délivrance Artificielle+ Révision Utérine (DARU) : 12%
  - Hystérectomie par Voie Haute (HVH ) : 3%
  - Révision Utérine (RU) SEULE : 45%
  - AUTRES : 8%

# Résultats

## Evolution

- **Pronostic**
  - Complication obstétricale : 40 %
  - Complication maternelle : 5 %
  - Décès maternel **: 3%** (état de choc hypovolémique, HPP)
  - Mort-né frais **: 12%**

- **Durée hospitalisation : 5 jours**

- **Tx d'hémoglobine à la sortie : 8,1g/dl**

# Résultats

## Contribution globale du NASG

- Stabilisation hémodynamique : **88,5 %** des cas
- Réduction des pertes sanguines : **98,4 %** des patientes
- Amélioration de l'état clinique : **91,8 %** des cas
- Récupération rapide de la tension artérielle systolique (≥90 mmHg) **dans un délai de 15 à 30 minutes** chez près de **85 %** des patientes

# Conclusion

- **Utilisation du Non Pneumatic Anti-Shock Garment (NASG)** : **efficace** dans la prise en charge des hémorragies obstétricales sévères associées à un choc hypovolémique ou à une instabilité hémodynamique
- Recommandations aux autorités sanitaires la mise à disposition du pantalon antichoc dans les hôpitaux du pays

# Merci pour votre attention

***Nos remerciements au DS/DAFRA et à l'ONG MSF-E***